

Carcinoma Basocelular (CBC)

(Basado en Guías MINSAL Chile 2023, NCCN Guidelines 2024, American Academy of Dermatology 2024, Fitzpatrick's Dermatology 2023, y UpToDate 2025).

1. Introducción y relevancia clínica

El **carcinoma basocelular (CBC)** es el **cáncer de piel más frecuente en el ser humano**, representando el **70–80% de los tumores cutáneos malignos**.

Surge a partir de las **células basales de la epidermis** y, aunque su **potencial metastásico es extremadamente bajo**, puede causar **gran destrucción local** por invasión profunda si no se trata oportunamente.

Relevancia clínica

- Es la neoplasia más diagnosticada en Chile y en el mundo.
- Su aparición se asocia con **exposición solar crónica** y **fototipo claro (I–III)**.
- No produce metástasis, pero su **crecimiento local infiltrante** puede comprometer **estructuras nobles (ojos, nariz, orejas, hueso)**.
- En EUNACOM, es clave reconocer su **clínica típica (pápula perlada con telangiectasias y ulceración central)** y su **manejo quirúrgico curativo**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Origen y patogenia

El CBC deriva de las **células madre basales** de la epidermis o del epitelio folicular.

Su desarrollo está ligado al **daño acumulativo por radiación UV**, que produce **mutaciones del ADN** y activación de la vía **Hedgehog** (mutaciones en genes *PTCH1* y *SMO*).

2.2. Factores de riesgo

Categoría	Ejemplos

Ambientales	Exposición solar crónica, radiación UV, cámaras de bronceado
Raciales / genéticos	Piel clara, ojos claros, antecedentes familiares, xeroderma pigmentoso
Inmunológicos	Inmunosupresión (trasplantados, VIH)
Antecedentes locales	Cicatrices, úlceras crónicas, exposición a arsénico, radioterapia previa
Edad y sexo	Predomina en >50 años, hombres (2:1)

2.3. Subtipos histológicos

Tipo	Características clínicas	Comportamiento
Nodular (clásico)	Pápula perlada, telangiectásica, a veces ulcerada ("úlcus rodens")	Más frecuente (60%)
Superficial	Placa eritematosa, descamativa, en tronco o hombros	Crecimiento lento
Morpheaforme (esclerosante)	Placa indurada, cicatricial, bordes mal definidos	Infiltrante, más agresivo
Pigmentado	Pápula o nódulo marrón-negruzco	Frecuente en fototipos altos
Fibroepitelial (de Pinkus)	Lesión pediculada o papilomatosa	Raro, de bajo riesgo

2.4. Mecanismos de invasión

Aunque el CBC rara vez metastatiza, **invade localmente** destruyendo piel, cartílago, hueso y, en casos avanzados, estructuras profundas (nariz, órbita, cráneo).

El riesgo de recurrencia o invasión aumenta con:

- Tamaño >2 cm.
- Localización en zonas de alto riesgo (cara central, nariz, orejas, párpados).
- Subtipo morpheaforme o infiltrante.
- Márgenes quirúrgicos positivos o recidiva previa.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión típica

- **Pápula o nódulo perlado**, brillante, color piel o rosado.
- **Telangiectasias** en la superficie.
- Puede ulcerarse en el centro, formando la “**úlcus rodens**” (borde elevado, centro deprimido y costroso).
- Crecimiento lento y progresivo durante meses o años.
- Suele sangrar con facilidad o formar costras persistentes.

3.2. Localización

- Zonas fotoexpuestas: **cara (nariz, párpados, mejillas, orejas), cuello, cuero cabelludo calvo**, dorso de manos.
 - Rara vez en mucosas o palmas.
-

3.3. Subtipos clínicos comunes

1. **Nodular:** lesión perlada con telangiectasias y ulceración central.
 2. **Superficial:** placa eritematosa con bordes finos, en tronco.
 3. **Pigmentado:** similar a melanoma, pero con borde perlado y telangiectasias.
 4. **Morpheaforme:** placa cicatricial dura, mal definida, sin borde perlado.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Enfermedad	Diferencias principales
Carcinoma espinocelular (CEC)	Lesión indurada, costrosa, dolorosa, con queratina central; más rápida evolución
Melanoma pigmentado	Lesión irregular, asimétrica, color heterogéneo, sin borde perlado
Queratosis seborreica	Placa verrucosa, aspecto “pegado”, sin telangiectasias
Queratosis actínica	Placa áspera, eritematosa, con descamación fina
Nevus melanocítico	Lesión estable, simétrica, sin ulceración

3.5. Signos de alarma

- Ulceración persistente.
- Sangrado espontáneo o recurrente.
- Crecimiento progresivo o bordes mal definidos.

- Dolor o invasión de estructuras adyacentes.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **clínico apoyado por dermatoscopia**, y se **confirma con biopsia**.

4.2. Dermatoscopía

Patrón típico del CBC:

- Telangiectasias arboriformes.
 - Nódulos perlados.
 - Áreas ovoides azul-grisáceas.
 - Ausencia de red pigmentaria regular (diferencia con nevus o melanoma).
-

4.3. Biopsia

Obligatoria para confirmar el diagnóstico.

Tipos:

- **Incisional o punch** si la lesión es grande o facial.
- **Escisional** si pequeña y fácilmente resecable.

Histología característica:

- Células basaloideas con palizadas periféricas.
- Hendiduras entre tumor y estroma.
- Mucina estromal y mitosis escasas.

4.4. Estudios de extensión

Solo en casos avanzados o infiltrantes:

- **TC o RMN:** compromiso óseo u orbitario.
 - **Ecografía ganglionar o PET-CT:** muy raro, solo en sospecha de metástasis.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

5.1. Objetivo

- Curación completa.
 - Máxima preservación funcional y estética.
 - Evitar recidivas.
-

5.2. Tratamiento quirúrgico (de elección)

Tipo de cirugía	Indicaciones	Márgenes recomendados
Escisión simple	Lesiones pequeñas, bien delimitadas	4 mm (riesgo bajo) o 5–10 mm (riesgo alto)
Cirugía de Mohs (micrográfica)	Lesiones faciales, recidivadas o infiltrantes	Control histológico inmediato de márgenes
Curetaje y electrocoagulación	Lesiones <1 cm en tronco o extremidades	No recomendado en cara

Criocirugía	Pacientes inoperables o lesiones pequeñas	Menor control histológico
--------------------	---	---------------------------

La **cirugía de Mohs** ofrece la mayor tasa de curación (>99%), especialmente en áreas estéticas o recidivas.

5.3. Tratamientos no quirúrgicos (según subtipo y tamaño)

Modalidad	Indicaciones	Observaciones
Imiquimod 5% tópico	CBC superficial, <2 cm	Aplicar 5x/semana por 6 semanas; inflamación local frecuente
5-Fluorouracilo tópico 5%	Alternativa para lesiones superficiales	Menor eficacia
Terapia fotodinámica (ALA + luz roja)	CBC superficial o múltiple	Buen resultado estético, alto costo
Radioterapia	Pacientes no quirúrgicos o mayores	Riesgo de recurrencia a largo plazo
Inhibidores Hedgehog (vismodegib, sonidegib)	CBC metastásico o localmente avanzado no operable	Uso especializado; efectos adversos frecuentes (alopecia, calambres, disgeusia)

5.4. Seguimiento

- Control dermatológico cada **6–12 meses** durante los primeros 2 años.
- Luego **anualmente de por vida**, por riesgo de nuevos CBC o CEC.
- Enseñar **autoevaluación mensual** y fotoprotección diaria.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Recurrencia local	Si resección incompleta o subtipo infiltrante
Invasión local	Hueso, cartílago, órbita
Desfiguración	Especialmente en zonas faciales
Metástasis	Excepcional (<0,1%)
Cáncer cutáneo múltiple	Riesgo aumentado de otros CBC o CEC

Pronóstico:

- **Excelente:** >95% de curación con cirugía adecuada.
- Riesgo de **nuevo CBC** en 30% a 5 años, por daño solar acumulado.
- Requiere **seguimiento dermatológico permanente**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Lesión típica: **pápula perlada, telangiectásica, con ulceración central** (“**úlcerus rodens**”).

2. Localización más frecuente: **cara y zonas fotoexpuestas**.
 3. **No metastatiza**, pero **invade localmente**.
 4. **Tratamiento quirúrgico (resección o Mohs)** es el estándar.
 5. En lesiones superficiales, pueden usarse **imiquimod o terapia fotodinámica**.
 6. **Diagnóstico confirmatorio siempre por biopsia**.
 7. En **EUNACOM**, la clave está en diferenciarlo de CEC (rápido, queratósico) y melanoma (asimétrico, irregular).
-



Errores comunes

- Asumir que “no es grave” y retrasar tratamiento.
 - No realizar biopsia previa en lesiones atípicas.
 - Usar crioterapia o láser sin confirmación histológica.
 - No controlar márgenes quirúrgicos en áreas de alto riesgo.
 - Olvidar seguimiento a largo plazo (riesgo de nuevos CBC).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **carcinoma basocelular** es el **cáncer cutáneo más frecuente**, de crecimiento lento y localmente invasivo.
2. Su **lesión clásica** es una **pápula perlada con telangiectasias y ulceración central**, en zonas fotoexpuestas.
3. El **diagnóstico se confirma con biopsia**, apoyado por dermatoscopia.
4. El **tratamiento de elección es quirúrgico** (resección completa o cirugía de Mohs).

5. El **pronóstico es excelente**, pero requiere **seguimiento por riesgo de recurrencia y nuevos tumores**.
6. La **fotoprotección diaria** es la principal medida preventiva.
7. En **EUNACOM**, la diferencia clave es:
 - **CBC**: pápula perlada + telangiectasias.
 - **CEC**: costrosa, dolorosa, rápida.
 - **Melanoma**: asimétrica, color irregular, evolutiva.